

Université MENTOURI 3
Faculté de médecine chalet des pins Constantine
Module de gastroentérologie
4 Emme année de médecine



Conduite à tenir devant une hépatomégalie

Dr. MENOURA. R

Maitre-assistant Hepato-biliopancreatique

Service de chirurgie digestive et endocrinienne

E.H. DIDOUCHE MOURAD

CONSTANTINE 2024/2025

Définition

L'hépatomégalie désigne une augmentation anormale du volume du foie, détectable à la palpation sous le rebord costal droit. Elle peut être diffuse ou localisée, homogène ou hétérogène, et est souvent le signe d'une pathologie hépatique sous-jacente.

Taille normale du foie

- À la percussion : matité hépatique ≤ 12 cm en ligne médio-claviculaire droite.
- À l'échographie : grand axe du lobe droit ≤ 15 cm.

Rappel anatomique du foie

1. Localisation

- Situé dans l'**hypochondre droit**, étendu jusqu'à l'épigastre et parfois l'hypochondre gauche.
- Protégé en grande partie par la cage thoracique (côtes 7 à 11).
- Le bord inférieur peut devenir palpable sous le rebord costal en cas d'hépatomégalie.

2. Morphologie

- Organe **volumineux** (environ 1,5 à 2 kg chez l'adulte).
- Divisé en **2 lobes anatomiques** (droit et gauche) par le ligament falciforme.
- Classification fonctionnelle en **8 segments de Couinaud**, chacun ayant son pédicule vasculaire et biliaire propre (utile en chirurgie et radiologie).

3. Vascularisation

• *Afflux sanguin mixte :*

- **Veine porte hépatique (70–75%)** : sang veineux riche en nutriments venant du tube digestif.
- **Artère hépatique (25–30%)** : sang artériel riche en oxygène.

• *Drainage :*

- Par **3 veines hépatiques** (droite, moyenne, gauche) → Veine cave inférieure.

4. Voies biliaires

- Foie produit la bile → canaux biliaires intra-hépatiques → conduit hépatique commun → canal cholédoque → duodénum (via ampoule de Vater).

5. Fonctions hépatiques

- **Métabolisme** des glucides, lipides, protéines
- **Synthèse** : albumine, facteurs de coagulation
- **Stockage** : glycogène, vitamines (A, D, B12), fer
- **Détoxification** : médicaments, ammoniacque (→ urée)
- **Sécrétion biliaire** (digestion des lipides)

III. Interrogatoire orienté

Objectifs :

Identifier des éléments d'orientation vers une étiologie.

Points clés :

- **Terrain** : âge, antécédents médicaux, consommation d'alcool, voyage, facteurs de risque viral.
- **Symptômes associés** :
 - Fièvre, fatigue, amaigrissement (infection, tumeur)
 - Douleur hépatique (abcès, congestion)
 - Ictère (hépatite, obstruction biliaire)
 - Signes d'insuffisance cardiaque droite
- **Traitements récents** (toxicité médicamenteuse)
- **Exposition professionnelle ou alimentaire** (toxiques, champignons, métaux lourds)

IV. Examen clinique

Inspection

- Ictère
- Circulation collatérale abdominale (hypertension portale)
- Amaigrissement

Palpation

- **Foie palpable sous le rebord costal droit**
- Consistance :
 - **Mou** : foie congestif ou stéatosique
 - **Dur ou pierreux** : foie tumoral ou cirrhotique
- **Surface** : régulière (bénin), irrégulière (cirrhose, tumeur)
- **Douleur à la palpation** : fréquente dans les hépatites aiguës, abcès ou congestion

Percussion

- Évaluation de l'extension de la matité hépatique

Recherche d'autres signes :

- **Splénomégalie** : hépatosplénomégalie
- **Signes d'HTP** : ascite, circulation veineuse collatérale
- **Signes d'IC droite** : œdèmes, turgescence jugulaire

V. Examens complémentaires

1. Biologie

- **Bilan hépatique** :
 - **ASAT, ALAT** : cytolyse
 - **Phosphatases alcalines, GGT** : cholestase
 - **Bilirubine totale et conjuguée**
 - **Albumine, TP** : fonction hépatique
- **Bilan étiologique orienté** :
 - Sérologies virales : VHB, VHC, EBV, CMV
 - Ferritine, coefficient de saturation de la transferrine (hémochromatose)
 - Céruloplasmine, cuivre libre (Maladie de Wilson)
 - Auto-anticorps hépatiques (ANA, ASMA, anti-LKM1, AMA)
 - Marqueurs tumoraux (AFP, CA19-9)

2. Imagerie

- **Échographie abdominale** : examen de 1ère intention
 - Taille du foie
 - Aspect échogène (stéatose, nodules, tumeur)
 - Vascularisation (Doppler hépatique)
- **Scanner abdomino-pelvien** : exploration plus précise (lésions tumorales, vasculaires)

- **IRM hépatique** : pour caractérisation des lésions focales
- **Fibroscan** : évaluation de la fibrose

3. Autres examens selon contexte

- **Biopsie hépatique** : dans les hépatopathies chroniques indéterminées
- **Ponction d'abcès** : si collection suspectée
- **Électrophorèse des protides** : myélome, syndrome inflammatoire

Étiologies de l'hépatomégalie

I clinique

1. Hépatomégalie homogène et diffuse

- **Hépatites aiguës ou chroniques** : virales, alcooliques, médicamenteuses.
- **Stéatose hépatique** : alcoolique ou non alcoolique.
- **Surcharge en fer** : hémochromatose.
- **Insuffisance cardiaque droite** : foie cardiaque.
- **Syndrome de Budd-Chiari** : thrombose des veines hépatiques.
- **Cholestase prolongée** : obstacle sur les voies biliaires.

2. Hépatomégalie homogène et sectorielle

- **Cirrhose** : stade initial avec hépatomégalie, évoluant vers une atrophie.

3. Hépatomégalie hétérogène (nodulaire)

- **Tumeurs bénignes** : kystes, hémangiomes.
- **Tumeurs malignes** : carcinome hépatocellulaire, métastases.
- **Abcès** : bactériens ou parasitaires.

Il est utile de classer les causes en fonction du

II mécanisme physiopathologique :

1. Hépatomégalie par surcharge

- **Stéatose hépatique** (alcoolique, métabolique, médicamenteuse)
- **Hémochromatose**
- **Maladie de Wilson**
- **Amylose**

2. Hépatomégalie congestive

- **Insuffisance cardiaque droite**
- **Péricardite constrictive**
- **Syndrome de Budd-Chiari**

3. Hépatomégalie tumorale

- **Métastases hépatiques**
- **Carcinome hépatocellulaire (CHC)**
- **Tumeurs bénignes : hémangiome, adénome, hyperplasie nodulaire focale (HNF)**

4. Hépatomégalie infectieuse ou inflammatoire

- **Hépatites virales (A, B, C, E, EBV, CMV)**
- **Tuberculose hépatique**
- **Abcès hépatique (bactérien, amibien)**
- **Maladies auto-immunes (hépatite auto-immune, cirrhose biliaire primitive)**

5. Hépatomégalie par infiltration

- **Leucémies et lymphomes**
- **Histiocytoses**
- **Sarcoïdose**



Ponction-biopsie hépatique

- **Indications** : lorsque le diagnostic reste incertain après les examens cliniques, biologiques et d'imagerie.
- **Contre-indications** : troubles de l'hémostase non corrigés, ascite non contrôlée.
- **Méthode** : guidée par échographie ou TDM, réalisée de préférence dans le lobe droit du foie

VI. Principales situations cliniques

1. Hépatomégalie douloureuse fébrile

- **Abcès hépatique (amibien ou pyogène)**
- **Hépatite virale aiguë**
- **Leucémie aiguë**

2. Hépatomégalie indolore chez un patient alcoolique

- **Stéatose hépatique**
- **Cirrhose hépatique**
- **Carcinome hépatocellulaire**

3. Hépatomégalie avec signes d'IC droite

- Foie de stase
- Budd-Chiari

4. Hépatomégalie avec splénomégalie

- Leucémie, lymphome
- Cirrhose avec hypertension portale
- Maladie infectieuse systémique (mononucléose, brucellose)

VII. Conduite à tenir pratique

1. Hospitalisation si :

- Fièvre + douleur hépatique intense
- Signes de décompensation hépatique (encéphalopathie, hémorragie digestive)
- Hépatomégalie suspecte de tumeur

2. Traitement spécifique selon l'étiologie :

- **Antibiotiques** pour abcès
- **Traitement antiviral** (hépatites B/C)
- **Chimiothérapie ou immunothérapie** (tumeurs, lymphomes)
- **Phlébotomies, chélateurs** (hémochromatose, Wilson)
- **Mesures hygiéno-diététiques** (sevrage alcoolique, perte de poids)

VIII. Conclusion

L'hépatomégalie est un **signe clinique fréquent** et non spécifique. La **conduite à tenir repose sur un raisonnement clinique rigoureux** guidé par :

- La **sémiologie** (douleur, consistance, fièvre, ictère...)
- L'**interrogatoire ciblé**
- Les **examens paracliniques adaptés**